



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**TERM OF REFERENCE (TOR)
DIKLAT
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY
KOMPREHENSIF(PONEK)
PERSALINAN SUNGSANG, GEMELI DAN DISTOSIA
BAHU**

**MARET
2024**



TERM OF REFERENCE (TOR)

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rumah sakit PONEK 24 jam merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kegawatdaruratan dalam maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan kompetensi yang handal.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, Pemerintah menetapkan beberapa program nasional yang menjadi prioritas. Program prioritas tersebut yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan angka kesehatan ibu dan bayi. Untuk mencapai kompetensi dalam bidang tertentu, tenaga kesehatan memerlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku dalam pelayanan kepada pasien. Salah satu program dari program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) sehubungan dengan pemberian pelayanan kesehatan adalah Pendidikan dan Pelatihan PONEK di Pelayanan Kesehatan.

Untuk itu Rumah Sakit, sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sudah saatnya melaksanakan program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif). Untuk mencapai program ini dengan baik dan benar perlu mengadakan pelatihan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) tentang kegawatdaruratan obstetric dan neonatal terkait Pelayanan Kesehatan kepada seluruh staf rumah sakit.

a. Distosia Bahu

1. Pengertian

Distosia bahu adalah suatu kondisi kegawatdaruratan obstetric pada persalinan pervaginam dimana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah lahirnya kepala janin. Tingkat insidensi distosia bahu kurang lebih sebesar 0,6 hingga 1,4 dari seluruh persalinan pervaginam.

2. Penyebab Distosia Bahu

Ukuran bahu bayi yang lebih besar dari pada ukuran panggul ibu kecil atau janin berdada pada posisi yang salah (malpresentasi) ketika memasuki jalan lahir.

3. Penanganan Distosia Bahu

a. Teknik McRobert

Pada teknik ini, dokter akan mengarahkan ibu untuk menaikkan paha ke arah perut sehingga perut ibu menjadi metode tertekan. Teknik ini umumnya menjadi metode pertama dalam mengatasi distosia bahu.

b. Teknik suprapubic

Teknik ini hampir sama dengan McRobert tetapi dokter atau bidan akan menekan area di atas tulang kemaluan (suprapubik) ibu. Teknik ini dapat membuat bahu bayi menjadi perpindahan dan tidak tersangkut.

c. Teknik Rubin

Pada teknik ini dokter akan memasukkan dua jari dibawah bahu bayi untuk membantu memindahkan posisi bahu. Teknik ini dilakukan agar bahu bayi menjadi sejajar.

b. Persalinan Sungsang

1. Pengertian

Persalinan sungsang adalah proses persalinan pervaginam untuk janin malpresentasi bokong. Malpresentasi ini ditemukan pada 3-4% kehamilan aterm. Persalinan sungsang pervaginam dapat berupa persalinan spontan (spontaneous breech delivery) atau persalinan dengan ekstasi total (total breech extraction).

Pada persalinan sungsang spontan, janin dilahirkan dengan kekuatan mengejan ibu tanpa tenaga penolong. Sementara pada assisted breech delivery ada kombinasi tenaga penolong untuk melahirkan bagian tubuh janin diatas umbilicus.



Pada persalinaan dengan ektaksi total proses persaliann seluruhnya dibantu oleh tenaga penolong.

2. Teknik persalinaan sungsang

- Manuver bracht kelahiran janin sepenuhnya tergantung pada kekuatan mengejan ibu
- Manuver pinard digunakan untuk melahirkan lutut dan kaki janin.
- Manuver lovset digunakan untuk melahirkan bahu janin dengan melakukan rotasi pada tubuh janin.
- Manuver mauriceu digunakan untuk melahirkan kepala janin

c. Persalinaan Gemeli

1. Pengertian

Kehamilan kembar atau gemelli adalah suatu proses kehamilan dimana terdapat lebih dari satu janin di dalam rahim. Ibu yang telah diketahui mengandung janin kembar perlu mendapat perhatian dan pengawasan khusus dari segala pihak untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu kesehatan ibu dan janinnya selama masa kehamilan hingga melahirkan (Wiknjosastro, 2007, p.286). Ada dua jenis kembar berdasarkan dari proses terbentuknya yaitu monozigot dan dizigot. Monozigot adalah janin kembar yang berasal dari satu sel telur sedangkan dizigot adalah janin kembar yang berasal dari lebih dari satu telur mewakili setiap janin kembar yang ada.

Sepertiga dari keseluruhan kelahiran kembar di dunia adalah monozigot. Kembar dizigot terjadi ketika dua telur atau lebih yang matang secara bersamaan, setelah itu dibuahi oleh sperma. Sehingga, kedua sel telur yang matang tadi akan dibuahi dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan kembar monozigot berarti satu telur matang yang dibuahi oleh sperma, lalu membelah menjadi dua. Kondisi bayi kelak akan sangat berpengaruh dari proses pembelahan ini. (Manuaba 2007, p.464).

Pada dasarnya, proses melahirkan bayi kembar hampir mirip dengan proses melahirkan satu anak secara normal. Dokter akan memasang alat monitor pada perut ibu bersalin untuk memantau kondisi bayi-bayi Anda dalam kandungan. Setelah ketuban pecah, dokter mungkin memasang *fetal scalp clip* pada kepala bayi pertama untuk memantau aktivitas jantungnya. Kemudian, bayi akan dilahirkan satu per satu. Setelah bayi pertama lahir, pasien bisa beristirahat sebentar sembari dokter memeriksa posisi bayi kedua dan melakukan pemeriksaan vagina.

Tak lama setelah kelahiran bayi pertama, leher rahim akan membuka lagi untuk memberi jalan bagi bayi berikutnya. Jika ternyata bayi kedua (atau ketiga dan keempat) posisinya sungsang, dokter mungkin harus membenarkan dulu posisinya sebelum dikeluarkan. Dalam kasus yang sangat langka, bayi selanjutnya akhirnya harus dilahirkan lewat operasi caesar untuk mengurangi risiko terjadinya komplikasi.

2. Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Kesehatan No.1051 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)24 jam di Rumah Sakit.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh tenaga medis di rumah sakit agar mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif

b. Tujuan Umum

Meningkatkan pelayanan Maternal dan Neonatal yang bermutu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.



c. Tujuan Khusus

1. Terlaksananya manajemen pelayanan maternal dan perinatal dari aspek administrasi & Manajemen, kompetensi SDM, fasilitas dan sarana serta prosedur pelayanan Rumah Sakit.
2. Pembinaan dan pengawasan pelayanan maternal dan perinatal di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam menghadapi dan menangani kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Susunan Panitia

NAMA	TIM	TUGAS
Siti Zaimah Amd. Keb	Ketua Panitia	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
Triasih Amd.Keb	Sekretaris Acara (Notulen) PJ Pretest dan Posttest	bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen. Hasil akhir : 1) notulen 2) LPJ bertanggungjawab terhadap pembagian, pelaksanaan, penilaian pre-post test. Hasil akhir : rekap pre-post test
Elok Oktavia, A.Md.Kep	Moderator	bertanggungjawab sebagai moderator dan mengaktifkan tanya jawab peserta. Hasil akhir : ringkasan persesi dan tanya jawab
Aulia Paramita,Amd.keb	PJ Absensi,dan Operator	bertanggungjawab terhadap kelengkapan absensi dan menyiapkan serta membagikan kuesioner pelathan. Hasil akhir: rekap absensi dan kuesioner pelatihan bertanggungjawab terhadap slide materi dan sound system
Fifi Wahyuni Amd.Keb	Sie Dokumentasi dan sie konsumsi	bertanggungjawab sebagai fotografer. Hasil akhir : foto di LPJ bertanggungjawab terhadap konsumsi pematiri dan peseta
Elisa Lifatinnura Str.Keb	Sie Perlengkapan dan Sie Penunjang	Bertanggungjawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan alat2 yag belum tersedia saat acara bertanggungjawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan
Novi Ratnasari, S.E	Bendahara	Bertanggungjawab terhadap anggaran biaya kegiatan

2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) Tentang Pelatihan Persalinan Sungsang,gemelli dan Distosia Bahu, dilaksanakan 1 (Satu) hari menjadi 1 gelombang.

- a. Hari / Tanggal : Selasa, 05 Maret 2024
- b. Pukul : 11.30 - 14.00 wib
- c. Tempat : Hall Sakura lantai 5 Rumah Sakit Prima Husada Malang

3. Rencana Rapat Panitia

- a. Hari / Tanggal : Jum'at / 29 Februari 2023
- b. Pukul : 14.00 s/d 15.00
- c. Tempat : Ruang Maternitas



4. Sasaran atau Peserta

- a. PLT. Kabid Pelayanan Medis
- b. Kabid Keperawatan
- c. PLT. Kabid Penunjang
- d. Bidan Poli
- e. Bidan dan Perawat IGD
- f. Perawat IKO
- g. Perawat dan Bidan ICU
- h. Bidan Maternitas
- i. Bidan PIPP
- j. Bidan Klinik Mutiara Sehat
- k. Seluruh Tim Ponек

NO	PESERTA	JUMLAH
1	Kabid Pelayanan Medis	1
2	Kabid Keperawatan	1
3	PLT. Kabid Penunjang	1
4	Bidan RS	25
5	Bidan Mutiara Sehat	7
6	Perawat	43
Total		78

5. Susunan Acara Lengkap

JAM	DURASI	MATERI	PEMATERI
11.30-11.40	10 menit	Absensi	Panitia
11.40-11.45	5 menit	Safety Breafing	Panitia
11.45-12.00	15 menit	Pretest	Panitia
12.00-13.00	60 menit	Materi 1. Persalinan Sungsang 2. Gemeli 3. Persalinan dengan Distosia Bahu	dr. Aida Musyarofah SpOG
13.00-13.15	15 menit	Pembukaan sesi tanya jawab	Panitia
13.15-13.45	45 menit	Praktek	Panitia
13.45-13.55	10 menit	PostTes	Panitia
13.55-14.00	5 menit	Doa & Penutup	Panitia

6. Narasumber/Pemateri

dr. Aida Musyarofah Sp.OG

7. Media

- a. LCD
- b. Lapotop
- c. Sound system
- d. Alat Tulis

8. Metode

- a. Diskusi
- b. Demonstrasi
- c. Role Play
- d. Tanya Jawab

9. Kebutuhan Anggaran

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	KEGIATAN	KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA	SUMBER DANA
1.	Selasa, 5 Maret 2024	Pelatihan PONEK Sungsang, gemeli,	- Fee Pemateri 1. dr. Aida Sp. OG - Konsumsi Pemateri - Air Mineral 220 ml - Cetak sertifikat - Sewa Pantum Panggul DM-GP6631 advanced maternity palpation model (Poltekkes Ijen)	1 orang 1 orang Dus 78 orang 1Pantum	Rp. 250.000,- Rp. 20.000,- Rp. 63.000,- Rp.0 Rp. 300.000,-	PT DPM Dapur RS Prima Husada Malang Dapur RS Prima Husada Malang Internal Cetak Soft Copy PT DPM
TOTAL					Rp. 633.000,-	



III. MONITORING & EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring dilaksanakan saat persiapan pelaksanaan dan pembuatan pelaporan serta aplikasi lapangan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Evaluasi awal berupa pretest dan evaluasi akhir berupa post test dan dalam proses pelaksanaan (praktek) ada penugasan dan praktek/role play yang juga dilakukan penilaian.

2. Evaluasi

Evaluasi awal berupa pre test dan evaluasi akhir berupa post test dan dalam proses pelaksanaan (praktek) ada penugasan atau praktek/roleplay yang juga dilakukan penilaian.

IV. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif meliputi Persalihan Sungsang, Gemeli, persalinan dengan distosia bahu di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Suksesnya acara ini memerlukan dukungan dan Kerjasama dari seluruh staf yang ada dan agar tujuan orientasi tercapai sebagaimana yang diharapkan. Atas perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Malang, 19 Februari 2024

Mengetahui
Bagian Sumber Daya Manusia
RS. Prima Husada Malang

Ketua Panitia

Annadiva Fikri Chandra Maulana S.Psi

Siti Zaimah Amd.Keb

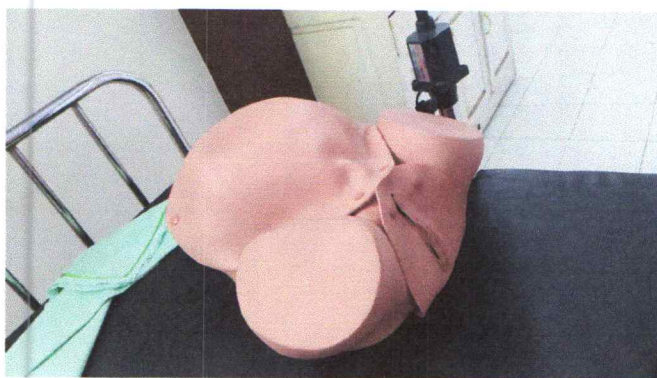
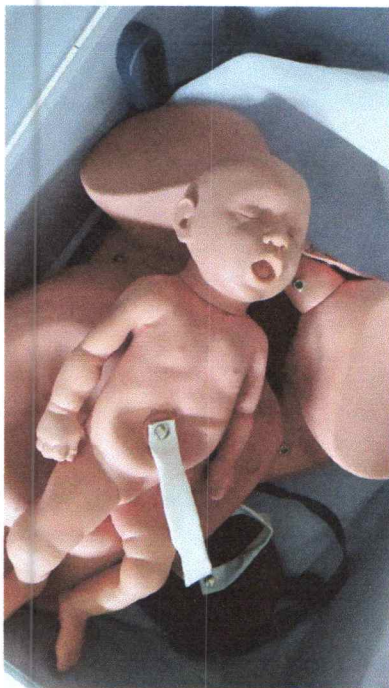
Disetujui Oleh,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah



LAMPIRAN

1. Sewa Pantum Persalinan



2. Harga Pantum Persalinan (No. 40)

A	B	C	D	E	F	G
34	Set Bidai			5	Rp 50.000	
35	Auscultation Simulator LSAT Gaumard			1	Rp 700.000	
36	DM-NS6036 Nasal Feeding and Gastric Lavage Simulator			2	Rp 300.000	
37	Advanced Male Chatheterisation Trainer			2	Rp 300.000	
38	Tensimeter aneroid			10	Rp 50.000	
39	Maternity examintaion model electric			1	Rp 500.000	
40	DM-GP6631 advanced maternity palpation model			2	Rp 300.000	
41	Advanced family planning education model			1	Rp 250.000	
42	DM-GP6624 IUD Training simulator II			1	Rp 250.000	
43	Advanced Subcutaneous Embedded Contraceptive Training Arm			1	Rp 200.000	
44	BVM			4	Rp 50.000	
45	Collar neck			5	Rp 50.000	
46	GD F7C Breast Examination Model			2	Rp 200.000	
47	Glucocheck (exclude stick, lancet, alcswab)			5	Rp 50.000	
48	Kendrick Extrication Device (KED),			1	Rp 200.000	

Sheet1 Surat



3. Daftar Nama Undangan Pelatihan Ponek

NO	UNIT	NAMA
1.	PLT Kepala Bidang pelayanan	dr. Wiryantati Akhdani Pratiwi
2.	PLT Kepala Bidang Penunjang	Putri Indah Purnamasari Amd.Keb
3.	Kepala Bidang Keperawatan	Very Susanto S.Kep.,Ns
4.	Kepala Unit MOD	Daning Pravitia YSM S.Tr.Keb
5.	Kepala Ruang Maternitas	Siti Zaimah Amd.Keb
6.	Kepala Ruang IRJA	Puput Sekar Nariratih,Amd.Keb
7.	Kepala Ruang IKO	Ns. Siti Durotul Ibadiyah.S.Kep
8.	Kepala IGD	Afni Nur Ainy S.Kep.Ns
9.	Kepala Ruang ICU	Ns. Risma Indra Setiyani S.Kep
10.	Maternitas	Triasih Amd.Keb
11.	Maternitas	Uswatul Chorida Amd.Keb
12.	Maternitas	Elok Oktaviana Amd.Keb
13.	Maternitas	Aulia Paramita Amd.Keb
14.	Maternitas	Elisa Lifatinnura,Str.Keb
15.	Maternitas	Faiza Muawanah Z.SST
16.	Maternitas	Putri adi Ara Ramadhania Amd.Keb
17.	Maternitas	Fifi wahyuningsih Amd.Keb
18.	Maternitas	Novita Rosunah Amd.KebM
19.	Maternitas	Ria Widyawati Amd.Keb
20.	Ponek IGD	Anggarani Dwi Pratiwi,Amd.Keb
21.	Ponek IGD	Wahyuni Amd.Keb
22.	Penek IGD	Nining Trisari Am.Keb
23.	Ponek IGD	Indrikhatul Inaya S.ST.Keb
24.	IRJA	Tuti Dwi Jayanti Amd.Keb
25.	IRJA	Leny Puji Rahayu Amd.Keb
26.	IRJA	Aneta putri Amd.Keb
27.	IRJA	Hana Hamimah Amd.Keb
28.	PIPP	Novita Pratama maulida Am.Keb
29.	IGD	Lita Oktavian Amd.Kep
30.	IGD	Benny wahyudi,S.Kep.Ns
31.	IGD	Rizal Ari Wicaksono Amd.Kep
32.	IGD	Kholilul Rohman Amd.Kep
33.	IGD	Noor Rochman,STr.Kep
34.	IGD	Wijaya Risku Ramadhan Amd.Kep
35.	IGD	Roida Saputri, S.Kep.NS
36.	IGD	Dwinta Widya Navita,Amd.Kep
37.	IGD	Zahrocha Fathmanda R Amd.Kep
38.	IGD	Fakhrur Rifqi A S.Kep.Ns
39.	IGD	Rahma Yunita Amd.Kep
40.	IGD	Nungki Putri Pebrianti Amd,Kep
41.	IGD	Rani Karisma Rosul, S.kep,Ns
42.	IGD	Tiara Anggita Putri, S.kep.,Ns
43.	IGD	Rizki Esa Wisnu Wardhana.S.Kep.,Ns
44.	IGD	Shynta Dinar Audia,S.kep.,Ns
45.	IGD	Alfia Indrawati,Amd.Kep



46.	IGD	Indha Magfiroti,Amd.Kep
47.	ICU	Rita Purnama Sari S S.Kep
48.	ICU	Tatik Widayati,S.Kep
49.	ICU	Artika Wulandari S.Kep
50.	ICU	Agus Widodo Amd.Kep
51.	ICU	Ikha faridha Oktaviana Amd.keb
52.	ICU	Septian Tegus Imanda Amd.Kep
53.	ICU	Ferianto Hendri Cahyono Amd.Kep
54.	ICU	Ns.Achmad Rudy Harianto,S.Kep
55.	ICU	Ns. Bagus Ardiansyah Putra,S.Kep
56.	ICU	Michael Ardhi Brahmento Amd.Kep
57.	ICU	Lusianah nurul Islamiyah Amd.Kep
58.	ICU	Ns. Fariz Tiarawan F.C.S.Kep
59.	IKO	Rendy Adhiyatma Amd.Kep
60.	IKO	Kiki Sandra Amd.Kep
61.	IKO	Ns.Kurnia Setyawan S.Kep
62.	IKO	Anita sari Smd.Keb
63.	IKO	Ns.Yurike Devita S.Kep
64.	IKO	Eko Pambudi Amd.Kep
65.	IKO	Ns. Feri Kuswantoro S.Kep
66.	IKO	Ns.Agus Hendra s.Kep
67.	IKO	Mokhammad Andi Gusti W.P Amd.Kep
68.	IKO	Okky Taat Setyawan S.Kep,Ns
69.	Bidan Orientasi	Agustina Kusuma Wardhani, S. Tr, Keb
70.	Bidan Orientasi	Adhita Krisna Prastiti, S.Tr, Keb
71.	Bidan Orientasi	Nurul Azizah Jihad Fisabilillah, S.Tr, Keb
72.	Bidan Mutiara Sehat	Sella Retno Ningrum Str.keb
73.	Bidan Mutiara Sehat	Indah Setiya Wati Amd.Keb
74.	Bidan Mutiara Sehat	Dewi Mar'atul Afifah Amd.keb
75.	Bidan Mutiara Sehat	Ferawati Agustina Amd.Keb
76.	Bidan Mutiara Sehat	Ning Andriani Amd.keb
77.	Bidan Mutiara Sehat	Yulia Hadiningtyas Amd.keb
78.	Bidan Mutiara Sehat	Vela Sari Yustina Amd.Keb